

TEMA 6.29 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Trastorno De La Deglución

PERFIL EUNACOM 4.02.4.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Conceptos EUNACOM de Trastornos del Habla (La Clínica de las Afasias)

La afasia se define clásicamente como una disrupción neurológica y central del procesamiento y producción del lenguaje, habitualmente adquirida posterior a eventos vasculares encefálicos (ACV) que comprometen isquémica u hemorrágicamente los hemisferios dominantes del paciente. En medicina general, la diferenciación semiológica de la lesión es cardinal y topográfica.

1. Afasia de Expresión (La Afasia Motora de BROCA)

Constituye la inoperancia de emitir el mensaje articulado. El paciente sabe perfectamente lo que quiere decir, entiende a su interlocutor, pero es incapaz de armar la estructura fonético-motora verbal vocal para emitirlo fluidamente.

- **Sinonimia Perfil EUNACOM:** También llamada "Afasia Motora" o "Afasia de Expresión".
- **Clínica Clásica:** El relato patognomónico es el de un paciente que **"NO HABLA de forma fluida ni fluente (mutismo o lenguaje telegráfico) Y NO ESCRIBE"**. Es consciente de su falencia (Le frustra) pero conserva íntegramente toda su capacidad de comprensión anatómica.
- **Topografía de Oro Neurológica:** El "Área de Broca" asienta anatómicamente en el **LÓBULO FRONTAL IZQUIERDO** (Hemisferio dominante).

2. Afasia de Comprensión (La Afasia Sensitiva de WERNICKE)

Es la antítesis clínica en donde la lesión infarta el centro decodificador estricto del lenguaje. El aparato foniátrico motor del paciente funciona a inmaculada perfección, rústica letale de, pero procesa las palabras entrantes como "ruido en idioma alienígena" en su corteza auditiva secundaria, sin sentido gneral ni raciocinio.

- **Sinonimia Perfil EUNACOM:** También llamada "Afasia Sensitiva" o "Afasia de Comprensión".
- **Clínica Clásica:** El individuo cursa inmaculadamente con un discurso fluido y locuaz ("Jergafasia o palabrería fluente"), PERO carente de absolutamente todo significado cognitivo y lógica contextual. El patrón clásico es **"EL PACIENTE HABLA FLUIDO PERO NO ENTIENDE ABSOLUTAMENTE NADA DE LO QUE SE LE DICE (lenguaje hablado) NI LO QUE ESTÁ LEYENDO (lenguaje escrito)"**. Muchas veces cursan con Anosognosia (no saben que están enfermos ni que hablan incongruencias).
- **Topografía de Oro Neurológica:** El asombroso centro procesal "Área de Wernicke" se posiciona anatómicamente en el asombroso **LÓBULO PARIETAL (Y Temporal superior) IZQUIERDO**.

3. Consideraciones Neurológicas en ACV (El Signo Contralateral Vascular EUNACOM)

- Puesto que ambas áreas de asombroso y rotundo poder dominantes (Broca y Wernicke) asientan anatómicamente en el hemisferio letaloide **IZQUIERDO** del cerebro de una persona normal diestra; los accidentes vasculares isquémicos de la Arteria Cerebral Media Izquierda rústicos y extensos que ataquen u ocluyan estos centros fofos de lenguaje acarrearán sistemáticamente **Tractos piramidales motrices cruzados**.
- El patrón Otorrinoneurológico definitivo EUNACOM será: Una Afasia (Sea de asiduo Broca sensitiva o Wernicke asintomática motora) acompañada inexorablemente de una **EMIPARESIA o EMIPLEJÍA DERECHA rotunda letale inmaculada (Es decir, del lado inmaclado asidúa Contralateral al hemisferio Dañado)**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de setenta años con antecedente de ACV hace dos meses refiere que al tomar líquidos tose y a veces se atraganta. Su familia nota que tiene fiebre y tos persistente. ¿Cuál es el diagnóstico y la complicación más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastorno De La Deglución. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Disfagia orofaríngea: dificultad para iniciar el trago, regurgitación nasal, tos al tragar, riesgo de aspiración
- Causa más frecuente de disfagia orofaríngea: enfermedades neurológicas como ACV, Parkinson y ELA
- Disfagia mecánica: sólidos primero, luego líquidos; causas: carcinoma esofágico, estenosis benigna
- Disfagia motora: sólidos y líquidos desde el inicio; causa principal: acalasia
- Acalasia: falta de relajación del esfínter esofágico inferior más ausencia de peristalsis esofágica
- Estudio disfagia orofaríngea: videofluoroscopia de la deglución; esofágica: endoscopia o manometría
- Complicación principal disfagia orofaríngea: aspiración laríngea con neumonía aspirativa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNO DE LA DEGLUCIÓN)**PREGUNTA 1**

Un hombre de setenta años con antecedente de ACV hace dos meses refiere que al tomar líquidos tose y a veces se atraganta. Su familia nota que tiene fiebre y tos persistente. ¿Cuál es el diagnóstico y la complicación más probable?

- A)** Disfagia mecánica por tumor esofágico; la complicación es la obstrucción total
- B)** Disfagia orofaríngea neurológica post-ACV con neumonía aspirativa
- C)** Acalasia de inicio tardío; la complicación es el megaesófago
- D)** Globus faríngeo funcional; sin complicaciones esperadas
- E)** Estenosis esofágica benigna; tratar con dilatación endoscópica

PREGUNTA 2

Una mujer de treinta y cinco años refiere disfagia para sólidos y líquidos desde hace dos años. A veces tiene regurgitación de alimentos no digeridos. Ha bajado diez kilos. La endoscopia muestra esófago dilatado con esófago distal cerrado. La manometría muestra ausencia de relajación del EEI. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Carcinoma esofágico inferior; la disfagia mecánica progresiva es típica
- B)** Estenosis péptica por reflujo; tratar con inhibidores de bomba de protones
- C)** Acalasia; tratamiento con dilatación neumática o miotomía
- D)** Espasmo esofágico difuso; tratar con nitratos
- E)** Globus faríngeo psicógeno; tratar con fonoterapia

PREGUNTA 3

¿Cuál es la diferencia clave entre disfagia mecánica y disfagia motora?

- A)** La mecánica produce dolor al tragar; la motora es indolora
- B)** La mecánica afecta primero sólidos y luego líquidos; la motora afecta sólidos y líquidos por igual desde el inicio
- C)** La mecánica se presenta en jóvenes; la motora en adultos mayores
- D)** La mecánica es reversible con tratamiento; la motora es siempre permanente
- E)** No hay diferencia clínica entre ambas; solo se distinguen por endoscopia

RESUMEN: TRASTORNO DE LA DEGLUCIÓN

La disfagia es la dificultad para deglutir y puede ser de causa orofaríngea o esofágica. La disfagia orofaríngea ocurre cuando hay un problema en las fases oral o faríngea de la deglución, y se caracteriza por dificultad para iniciar el trago, regurgitación nasal, tos al tragar y aspiración. Las causas más frecuentes son neurológicas, especialmente el ACV, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. La disfagia esofágica ocurre cuando el problema está en el esófago y se caracteriza por sensación de que el alimento se queda a nivel del esternón después de iniciado el trago. En la disfagia esofágica es fundamental distinguir entre la disfagia mecánica y la disfagia motora. La disfagia mecánica u obstructiva es para sólidos inicialmente y luego progresa a líquidos a medida que el lumen se estrecha. Sus causas incluyen el carcinoma esofágico y la estenosis benigna. La disfagia motora afecta tanto sólidos como líquidos desde el inicio porque el problema no es el calibre sino la coordinación del movimiento esofágico. La acalasia es la causa más importante de disfagia motora: hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior y pérdida de la peristalsis esofágica. El diagnóstico de la disfagia se realiza con videofluoroscopia para la fase orofaríngea y endoscopia o manometría para la fase esofágica. La aspiración laringea es la complicación más grave de la disfagia orofaríngea y puede producir neumonía aspirativa. Los pacientes de alto riesgo de aspiración son los que tienen disfagia orofaríngea severa, especialmente neurológicos. El estudio de la disfagia en estos pacientes es la videofluoroscopia de la deglución que permite ver en tiempo real el paso del alimento.